Déclaration du Hub Mondial de Données pour le Plaidoyer (GADH) à la 56e réunion du Conseil d'administration du Fonds mondial

15 octobre 2026

Le Hub Mondial de Données pour le Plaidoyer (GADH) est une plateforme et un réseau portés par la société civile qui renforce le pouvoir des communautés dans toute leur diversité en leur fournissant les informations, les données, les ressources et le soutien dont elles ont besoin pour participer aux prises de décision en matière de santé aux niveaux national et mondial, et pour demander des comptes aux systèmes de santé et aux bailleurs de fonds. Le GADH vise à mettre les communautés au cœur de l'action et à leur donner les moyens d'agir, en particulier celles qui sont les plus touchées par les inégalités en matière de santé et souvent exclues des instances décisionnelles, en favorisant la transparence, en facilitant l'accès aux données, en générant des données issues des communautés et en encourageant le soutien entre pairs.

Le Hub Mondial de Données pour le Plaidoyer (GADH) reconnaît le contexte exceptionnellement difficile auquel est confronté le Fonds mondial. Alors que certains donateurs ont augmenté leurs contributions, la réduction et la non-conversion des engagements de plusieurs des plus grands donateurs du Fonds mondial ont entraîné des perturbations sans précédent au sein de l'ensemble du partenariat. Nous saluons les **efforts considérables déployés par le Secrétariat et le Conseil d'administration pour atténuer les effets néfastes** de ce retrait rapide des financements.

On ignore encore si le Fonds mondial parviendra à préserver les systèmes et infrastructures vitaux qu'il a contribué à mettre en place. Le calendrier de la 56e réunion du Conseil d'administration invite à une telle réflexion. D'ici fin 2026, le Comité d'examen technique aura examiné 86 % du portefeuille du Fonds mondial, et la mise en œuvre des subventions pour de nombreux pays débutera en janvier 2027. **Nous appelons le Conseil d'administration à prendre en compte les premiers signaux qui émergeront dès 2026**, tant qu'il est encore temps de combler les lacunes qui se dessinent.

Le GADH reconnaît les tensions majeures auxquelles sont confrontés le Secrétariat et le Conseil d'administration, qui doivent trouver un équilibre entre leurs responsabilités fiduciaires, leurs objectifs stratégiques et l'évolution de l'architecture mondiale de la santé. Nous considérons également cette nouvelle architecture comme une opportunité de renforcer stratégiquement les systèmes de santé et l'appropriation par les pays. Lors de cette réunion du Conseil d'administration, nous exhortons ce dernier à rappeler que **l'appropriation par les pays ne se limite pas au gouvernement, mais englobe également les communautés, les organisations de la société civile (OSC),** ainsi que les usagers des services de santé, le secteur privé, le personnel de santé, les organisations confessionnelles, le monde universitaire et bien d'autres acteurs. Protéger et placer au centre les communautés vivant avec ces trois maladies et les plus touchées par celles-ci s'inscrit dans la lignée de l'Accra Reset et de l'Agenda de Lusaka, et contribue à leur mise en œuvre.

Le Hub Mondial de Données pour le Plaidoyer (GADH) formule plusieurs recommandations destinées à éclairer les discussions du Conseil d'administration, sur la base des premiers résultats de l'étude Msingi. L'étude Msingi est une étude indépendante, menée par la société civile et utilisant des méthodes mixtes, dirigée par le Hub Mondial de Données pour le Plaidoyer, qui vise à documenter les expériences nationales en matière de planification de l'intégration des programmes et de la transition vers le Fonds mondial. À ce jour, 379 représentants des ICN et partenaires communautaires ayant pris part aux consultations du Fonds mondial y ont participé, avec des données provenant de 76 pays.

1. Veiller à ce que les cadres de reporting du Fonds mondial soient adaptés à leur objectif.

La stratégie 2023-2028 du Fonds mondial a été élaborée plusieurs années avant la huitième reconstitution des ressources et le lancement des « GC8 Shifts ». Le Conseil d'administration doit donc s'assurer que **ses mécanismes de suivi reflètent de manière adéquate l'impact des « GC8 Shifts »**, notamment en ce qui concerne l'intégration des programmes et la transition.

Le rythme rapide de l'intégration et de la transition est **motivé par l'incertitude financière, et non par l'état de préparation des pays**, comme le prévoyait historiquement la politique relative à la pérennité, à la transition et au cofinancement (STC). À ce titre, le cadre actuel des indicateurs clés de performance (KPI) doit être adapté afin de refléter les risques nouveaux et évolutifs associés aux « GC8 Shifts » ainsi qu'au contexte social, économique et politique actuel, à la fois difficile et en mutation rapide.

Nous demandons au Fonds mondial :

1. **De renforcer le suivi de la transition et de l'intégration.** Le Conseil d'administration du Fonds mondial doit exiger un suivi, une évaluation et un reporting adéquats concernant la transition et l'intégration des pays. Cela devrait inclure des rapports réguliers, notamment par le biais d'indicateurs clés de performance (KPI), avec une communication transparente au Conseil d'administration et aux partenaires.
2. **Mettre en place un mécanisme de reporting allégé pour les pays ayant achevé leur transition**, en partenariat avec ses partenaires techniques et avec la participation significative des communautés et des organisations de la société civile (OSC), en mettant l'accent sur la résurgence épidémiologique, les systèmes communautaires et la continuité des investissements programmatiques du Fonds mondial.
3. **Commander des évaluations des pays ayant achevé leur transition.** Le Bureau de l'inspecteur général (OIG) ou tout autre organisme d'évaluation indépendant devrait commander et publier une analyse rétrospective des pays ayant achevé leur transition au cours des 2 à 3 derniers cycles, y compris les transitions qui n'ont finalement pas permis de préserver les programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Cette analyse doit mettre en évidence des approches efficaces et reproductibles, ainsi que des enseignements clairs sur les raisons pour lesquelles les transitions peuvent échouer.

4. **Développer des partenariats pour garantir la supervision et le soutien après la transition.** Alors que le Secrétariat définit ses stratégies d'engagement dans la nouvelle architecture mondiale de la santé, il convient de donner la priorité à de nouveaux mécanismes et partenariats avec des partenaires techniques et d'autres organisations internationales qui maintiendront leur présence au-delà de la transition du Fonds mondial. Ces partenariats devraient faciliter le soutien aux activités de responsabilisation menées par la société civile et faciliter le suivi des résultats de la transition.

2. S'engager à respecter le principe fondamental de « ne pas nuire » dans la planification de l'intégration et de la transition.

Les conclusions de l'étude Msingi montrent clairement que, dans la plupart des pays, de sérieux obstacles à l'accès aux soins dans les structures de soins de santé primaires (SSP) restent sans solution. Il s'agit notamment de ressources humaines surchargées, de chaînes d'approvisionnement fragiles et de perturbations importantes dues à la résiliation des contrats avec le gouvernement américain. Dans de tels contextes, le transfert de la prestation de services vers les SSP risque de créer de nouveaux obstacles à l'accès aux soins pour les bénéficiaires soutenus par le Fonds mondial et pour le système de santé dans son ensemble.

De plus, des défis plus graves sont fréquemment signalés, notamment une application de plus en plus agressive de la criminalisation, la montée du mouvement anti-genre et des gouvernements d'extrême droite, la violence politique et les conflits militaires actifs. Dans de tels contextes, exiger la **transition et l'intégration dans les SSP est une question relevant des droits humains**. Il incombe au Fonds mondial de maintenir un niveau très élevé de vigilance et de connaissance de la situation dans la mise en œuvre des changements de la GC8.

Nous demandons au Fonds mondial :

5. **D'exiger des évaluations techniques des obstacles à la transition et à l'intégration lors de l'octroi des subventions.** Pour le reste des demandes de financement examinées dans le cadre du GC8, et dans la perspective du GC9, de fournir au Comité technique d'examen des propositions (CTEP) et au Comité d'approbation des subventions (GAC) une analyse suffisante des obstacles juridiques et réglementaires à l'intégration, à la transition et à la passation de marchés sociaux, afin de garantir que les subventions soient conçues pour combler ces lacunes. Cela va dans le sens des propres observations du CTEP, selon lesquelles 30 % des demandes de financement soumises lors des fenêtres 1 et 2 n'identifiaient pas les défis liés à la pérennité et à la transition et ne fournissaient pas de plans, d'actions et d'investissements clairs pour y remédier. Les évaluations de l'état de préparation à la transition fournies dans les demandes de financement doivent être complétées par une évaluation d'experts indépendants, en collaboration avec des partenaires techniques.
6. **Préserver le financement à double voie jusqu'à ce que tous les obstacles aient été raisonnablement surmontés.** Nous demandons instamment que la rationalisation des RP soit suspendue jusqu'à ce qu'une évaluation juridique et politique complète ait

démontré la capacité, la volonté et l'adéquation du RP gouvernemental – ou d'un autre bailleur de fonds – à prendre en charge les programmes mis en œuvre sous la responsabilité du ou des RP non gouvernementaux. Cela devrait au minimum inclure la preuve qu'il n'y a pas de sanctions pénales ni de risque d'arrestation pour les communautés accédant aux soins dans les structures de soins de santé primaires, ainsi que la mise en place d'un mécanisme de contrat social ou d'un autre mécanisme permettant aux organisations dirigées par la communauté de fournir des services animés par des pairs. En l'absence d'une telle documentation, le financement à double voie doit être préservé jusqu'à ce que le contexte national ait suffisamment évolué.

3. Renforcer la diffusion des recommandations et des informations relatives à l'intégration et à la transition.

Les conclusions de l'étude Msingi révèlent l'**absence d'une conception commune de l'intégration** dans de nombreux contextes. Alors que la plupart des parties prenantes entendent par « intégration » la prestation de services au sein d'un point de soins unique, on observe dans de nombreux contextes une pression croissante pour transférer l'ensemble des services vers les structures de soins de santé primaires, au détriment des services communautaires et ceux fournis par les organisations de la société civile. En l'absence de définitions claires et de directives concernant les normes minimales, cette ambiguïté peut être exploitée de manière à nuire aux soins axés sur la communauté.

Nous demandons au Fonds mondial :

7. **De publier des orientations claires et contraignantes concernant l'intégration.** De republier la note technique sur l'intégration sur le site web du Fonds mondial. Le retrait de ce document lors de l'élaboration des demandes de financement constitue un obstacle à l'accès aux informations de base et aux lignes directrices relatives à l'intégration. D'enrichir ces orientations par des exigences spécifiques et contraignantes concernant les critères minimaux de base pour une intégration réussie, conformément à la stratégie du Fonds mondial et à son engagement en faveur de l'accès aux soins et de la protection des droits de l'homme.
8. **Renforce le partage d'informations avec la société civile.** En collaboration avec les hubs d'apprentissage régionaux, renforce la sensibilisation et le partage d'informations concernant l'intégration et la transition afin de garantir que toutes les parties prenantes comprennent les concepts, les calendriers et les lignes directrices nécessaires pour s'impliquer de manière significative dans la prise de décision.
9. **Publie les plans de transition.** Afin de permettre une appropriation et un suivi partagés, les plans de transition doivent être accessibles au public et inclure des étapes mesurables menant à la préparation à la transition.

4. Tirer parti des exigences standard en matière de rapports pour améliorer la visibilité des investissements mondiaux dans le domaine de la santé.

Les conclusions de l'étude Msingi identifient la transparence comme un défi auquel est confronté l'ICN lors de l'élaboration des demandes de financement et de l'octroi des subventions. Il convient notamment de noter que la négociation simultanée d'accords de financement bilatéraux entre les gouvernements chargés de la mise en œuvre et le gouvernement américain a limité la visibilité dont disposait l'ICN sur l'ensemble des ressources disponibles pour les programmes de santé dans les pays. Parallèlement, la récente résiliation de subventions clés en matière de santé mondiale financées par le gouvernement américain a créé une confusion supplémentaire quant au paysage du financement. Tout en reconnaissant que les accords bilatéraux ne relèvent pas de la compétence du Fonds mondial, nous exhortons le Secrétariat à utiliser ses exigences existantes en matière de rapports pour promouvoir la transparence et le partage d'informations.

10. **Faciliter la visibilité des investissements bilatéraux dans le domaine de la santé.** Le Fonds mondial doit tout mettre en œuvre pour promouvoir la transparence des contributions gouvernementales bilatérales consacrées à la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Cela doit au minimum inclure l'obligation de collecter des données au niveau des modules concernant les sources de financement (dans le cadre du tableau « Funding Landscape » de la demande de financement) et de les inclure dans la version publiée du document sur le portail de données du Fonds mondial.

5. Mobiliser l'ensemble des capacités du Secrétariat pour garantir des transitions efficaces.

Les conclusions de l'étude Msingi, y compris celles issues de pays ayant déjà effectué leur transition, suggèrent que le Secrétariat du Fonds mondial joue un **rôle déterminant dans la réussite des transitions**. Les participants à l'étude soulignent le besoin urgent d'un engagement de haut niveau avec les gouvernements dans la planification de la transition, ainsi que d'investissements accrus dans la planification de la transition et de l'intégration. Nous sommes préoccupés par les conclusions selon lesquelles, dans certains contextes, les ICN ont, dans la pratique, cessé de fonctionner, en raison du retrait de l'ONUSIDA et de l'évolution des dynamiques politiques liée au départ d'alliés de longue date des communautés au sein des ICN.

En cette période charnière, nous estimons que le Fonds mondial a un rôle clé à jouer en s'appuyant sur l'ensemble des outils et de l'influence du Secrétariat, tout en préservant le principe fondamental de l'appropriation nationale.

Nous demandons au Fonds mondial :

11. **De s'assurer activement du bon fonctionnement des ICN.** Le Secrétariat doit vérifier que les perturbations liées à l'ONUSIDA et les fermetures de bureaux nationaux n'affectent pas le fonctionnement, la dotation en personnel et l'animation des ICN. Cela doit inclure un examen approfondi par le Comité d'examen de la conformité (CRP) de toutes les exigences minimales relatives au fonctionnement des ICN, y compris, mais

sans s'y limiter, l'exigence d'éligibilité n° 1 des ICN, conformément à la politique relative aux ICN et aux autres directives du Fonds mondial.

12. **Renforce son engagement de haut niveau auprès des gouvernements.** En cette période de profonde évolution du partenariat avec le Fonds mondial, le Secrétariat du Fonds mondial doit renforcer son engagement de haut niveau auprès des gouvernements concernant la transition. Cet engagement doit promouvoir non seulement des déclarations politiques, mais aussi des instruments juridiquement contraignants consignant les engagements des gouvernements à préserver les investissements du Fonds mondial au-delà de la transition et pendant l'intégration. Le Fonds mondial doit veiller à ce que les engagements qu'il sollicite auprès des gouvernements ne soient pas spécifiques à une administration ou à des individus, mais puissent plutôt survivre aux transitions de pouvoir, à la perte de mémoire institutionnelle et à l'évolution des contextes politiques et épidémiologiques nationaux.
13. **Protéger la voix des communautés au sein des ICN.** Au-delà de son engagement de haut niveau, le Secrétariat doit travailler en partenariat avec ses partenaires techniques pour protéger la voix des communautés et des OSC au sein des ICN et, dans la mesure du possible, dans d'autres instances nationales de responsabilisation. Il s'agit d'une priorité urgente, car les institutions qui défendaient auparavant les droits de l'homme et les activités axées sur les communautés (par exemple, le gouvernement américain et l'ONUSIDA) ont réorienté leurs priorités ou ont vu leur capacité à s'engager de manière adéquate diminuer. De plus, le Centre des ICN et le Bureau de l'inspecteur général (OIG) doivent renforcer la surveillance des représailles et des risques pour la sécurité, en particulier dans les contextes où ces activités sont criminalisées.
14. **Mobiliser des ressources pour intensifier les investissements catalytiques axés sur l'intégration et la transition.** Poursuivre des efforts énergiques pour mobiliser des ressources publiques et privées supplémentaires en faveur des priorités d'investissements catalytiques axées sur la transition et l'intégration approuvées par le Conseil d'administration, notamment « Soutenir la pérennité et la transition hors du financement du Fonds mondial », « S'attaquer aux obstacles liés aux droits de l'homme et au genre qui entravent l'accès aux services » et « Renforcer les réseaux communautaires et l'engagement pour faciliter l'accès aux services ». Les niveaux de financement doivent être suffisamment élevés pour assurer un soutien pluriannuel à l'ensemble du portefeuille. Ces ressources devraient servir à traiter de toute urgence les risques pesant sur les programmes axés sur les communautés (y compris les obstacles liés aux droits de l'homme et au genre) pendant la phase d'intégration et au-delà de la transition, à soutenir le plaidoyer mené par les communautés, à assurer le suivi et l'évaluation du système de soins de santé primaires (SSP) menés par la société civile, ainsi qu'à financer la formation et le renforcement des compétences nécessaires pour rendre les cliniques intégrées sûres et accessibles.

6. Traiter de toute urgence le risque accru d'effondrement de la société civile après la transition.

Les données de l'étude Msingi montrent clairement que **les ressources du Fonds mondial constituent la dernière source de financement restante pour les organisations dirigées par la communauté et les OSC** qui fournissent des services de santé, plaident en faveur de systèmes de santé responsables et apportent le soutien par les pairs nécessaire pour garantir que toutes les personnes vivant avec et touchées par les trois maladies bénéficient de soins de santé. Les contrats sociaux constituent une voie permettant de rembourser les services dirigés par la communauté et de soutenir la société civile. Cependant, les données de Msingi indiquent que les mécanismes de contrats sociaux ne fonctionnent pas dans la plupart des pays, et peu de voies de financement alternatives pour les organisations communautaires ont été identifiées. Les preuves de la dissolution d'organisations de la société civile dans les pays en phase post-transition soulignent ce risque aigu.

Nous notons en outre que, dans de nombreux pays, la création des **ICN a ouvert des possibilités d'engagement et de responsabilisation qui n'étaient pas disponibles auparavant** pour les communautés. Cependant, les données de Msingi suggèrent que les ICN fonctionnels ne perdurent généralement pas au-delà de la transition. Tout en reconnaissant que les ICN ont été conçus pour le modèle d'octroi de subventions du Fonds mondial, nous exhortons ce dernier à prendre conscience que, dans les contextes post-transition, l'absence d'espaces de responsabilité démocratique risque de compromettre plus de deux décennies d'investissement dans les systèmes de santé. Les données de Msingi mettent en outre en évidence un manque préoccupant de visibilité sur les données gouvernementales ventilées concernant les budgets, les dépenses et les résultats des programmes, ce qui affaiblit encore davantage le contrôle exercé par les gouvernements.

Nous demandons au Fonds mondial :

15. **D'investir dans la transparence gouvernementale.** Les investissements du Fonds mondial dans les systèmes de données et la santé numérique doivent inclure des investissements dans la transparence publique fondamentale des budgets, des dépenses et des résultats des programmes gouvernementaux. Cela devrait inclure les investissements réalisés dans le cadre des subventions de la GC8, ainsi que l'Initiative stratégique « Accélérateur d'impact de la santé numérique » et les fonds de contrepartie pour la gestion des finances publiques et les solutions numériques favorisant l'intégration.
16. **Crée des mécanismes de financement multipays pour soutenir la responsabilisation.** Dans le cadre de la GC9, utilise des investissements catalytiques pour soutenir une modalité de financement multipays destinée aux activités de plaidoyer, de contrôle et de responsabilisation menées par la société civile dans les pays en transition et post-transition. Nous suggérons que ces investissements soient réalisés par le biais d'un mécanisme multipays, afin de réduire la charge administrative pesant sur le Secrétariat, et qu'ils comprennent des ressources suffisantes pour compléter les budgets propres des ICN consacrés à l'engagement communautaire (c'est-à-dire 15 % de l'accord de financement des ICN, conformément au Manuel des politiques opérationnelles du Fonds mondial) pendant au moins un cycle d'allocation post-transition. Ces ressources devraient s'accompagner d'une assistance technique

axée sur les obstacles juridiques à l'appropriation par les gouvernements, au suivi des budgets nationaux et à d'autres thèmes ciblés liés à la transition.

17. **Exiger des démonstrations à grande échelle de contrats sociaux.** Utiliser les investissements catalytiques pour soutenir l'élaboration et la mise en œuvre de cadres juridiques et politiques permettant la conclusion de contrats sociaux et pérennisant la prestation de services dirigée par les communautés et les OSC au-delà des projets à petite échelle.

Contact : info@globaladvocacydatahub.org